

DEMENTIA PRAECOX Y PARANOIA

PRÓLOGO — Colección *Clínica y Psicopatología: Los conceptos y su historia*

Autor de la obra: Emil Kraepelin (1899)

Traducción y Prólogo a cargo de: Lic. Nora Carbone y Dr. Gastón Piazze (con la colaboración de Julia Martín)

Editorial: De la Campana (La Plata, 2005) · Dirección de colección: Graciela Napolitano

Asignación académica: Clase 2 — Historia y paradigmas de la psiquiatría (Psicopatología I · UFLO Online 2026)

El año 1856 alumbró tres figuras que serían decisivas para el destino de la patología mental: el francés Jules Séglas, el austriaco Sigmund Freud y el alemán Emil Kraepelin. Al primero debemos invalorable contribuciones a la semiología psiquiátrica, entre las que destacamos la introducción de las alucinaciones en el campo de los trastornos del lenguaje. Al segundo, la invención de una nueva manera de intervenir sobre el padecimiento psíquico, solidaria de una radical subversión de los fundamentos psicopatológicos ortodoxos. Ahora bien, ¿cuál es el aporte de quien fuera llamado el «kaiser» de la psiquiatría alemana al heterogéneo ámbito de estudio de las afecciones mentales?

Desde sus primeros años de formación médica, Emil Kraepelin se interesó en las enseñanzas impartidas por Wilhelm Wundt, fundador del primer laboratorio de Psicología experimental. De él extrajo la convicción de que la psicología normal podía resultar útil para entender las enfermedades mentales, base del análisis psicológico descriptivo que atravesaría luego todo su sistema nosográfico. También de él recibió el impulso para abocarse de lleno a la psiquiatría, campo en el que, según su maestro, encontraría «mejores oportunidades». Movidio por el temor a padecer estrecheces económicas y por la necesidad de mejorar su situación curricular, en 1883 Kraepelin publicó un pequeño texto, el *Compendium der Psychiatrie*, a pedido de una editorial. La insatisfacción por los resultados obtenidos («*escribiendo el libro quedaron claros para mí los escasos alcances de mis conocimientos psiquiátricos, y lamenté amargamente no poder llenar sus lagunas con observaciones hechas a la cabecera de los enfermos*»¹) se tornó fecunda en su vasta producción posterior: el *Lehrbuch*, labor monumental llevada a cabo en sucesivas ediciones a lo largo de más de treinta años.

La meticulosa observación y el interés por clasificar las manifestaciones mórbidas convierten a Kraepelin en uno de los principales exponentes de la psiquiatría considerada como una ciencia natural. Su mirada, al comienzo pineliana, se inscribió de manera paulatina en la tradición fundada por Bayle, Falret y Kahlbaum, orientándose hacia una perspectiva diacrónica, etiológica y psicopatológica que elevó a la entidad clínico-evolutiva a su máxima expresión. Es justamente su afán por articular estos tres ejes lo que vertebra la sexta edición del Tratado y le otorga una consistencia distintiva en el conjunto de su obra:

«Si tuviéramos un conocimiento exhaustivo de todos los detalles de cada uno de los tres campos de la locura —anatomía patológica, etiología y sintomatología—, entonces no sólo sería posible arribar a la clasificación concienzuda y uniforme de las psicosis sobre la base de cada campo, sino que cada una de esas tres agrupaciones —y este requisito es la verdadera llave de nuestra investigación científica— también coincidiría en esencia con las otras dos.»²

Con respecto al primer campo mencionado, el correspondiente al método anatómo-patológico, debe señalarse que la posición de Kraepelin no era tan ingenua como la de Bayle, en la medida en que reconocía que no era posible su plena aplicación a la totalidad de la patología mental. No obstante, su adhesión al paralelismo psicofísico como ideal

que sostenía el paradigma de las verdaderas enfermedades se advierte en la distribución que hizo de las mismas de acuerdo a su causa externa o interna. En ambos casos está presente la referencia orgánica, sea bajo la forma de lesiones, intoxicaciones o infecciones, sea bajo la forma de la predisposición de un cerebro constitucionalmente «tarado».

El criterio etiológico aparece entonces como un organizador de las trece clases que incluye la nosografía, ordenadas según el predominio causal, desde las más exógenas hasta las más endógenas. Sin embargo, la falta de datos etiopatogénicos certeros en gran parte de los casos hizo que Kraepelin apelara a la perspectiva clínico-evolutiva, bajo la premisa de que marchas clínicas similares permitían inferir causas análogas. El punto de vista diacrónico que, como hemos indicado con anterioridad, proviene de la escuela francesa, adquiere una impronta particular con el privilegio que Kraepelin otorgó al estadio terminal, denominador común que le posibilitó unificar sintéticamente cuadros clínicos heterogéneos.

El singular enfoque clínico-evolutivo de este autor se especifica en la división que hizo entre síntomas fundamentales y síntomas accesorios: son los primeros —fenómenos propios y constantes del cuadro mórbido— los que se expresan en su «máxima pureza» en la fase terminal, mientras que los segundos, si bien matizan las formas clínicas, sólo son manifestaciones más incidentales y transitorias del proceso de la enfermedad (que suelen retroceder ante los cambios permanentes y característicos de la vida mental)³. Este binomio se convierte en el pivote alrededor del cual se delimitan las distintas categorías nosográficas, a la par que constituye la tabla de orientación para el clínico quien, a partir de la detección de ciertos signos capitales presentes desde el comienzo, podrá predecir el desenlace típico de cada enfermedad:

«Lo primero que el médico tiene que hacer junto al lecho del enfermo es formarse una opinión sobre el futuro desarrollo del caso. Este es siempre el primer problema que se le plantea. Para la actividad práctica del clínico, el valor de todo diagnóstico radica esencialmente en la capacidad de establecer pronósticos fidedignos acerca del futuro.»⁴

Finalmente, debe agregarse que la caracterización clínico-evolutiva se funda en el análisis de los desórdenes que se presentan en las diferentes esferas de la personalidad, lo que hace del criterio psicopatológico descriptivo otro de los vectores que sustentan la clasificación. Fiel al modelo médico de su época —en el que la fisiología proporcionaba la norma en relación con la cual la enfermedad se concebía como un funcionamiento desviado—, Kraepelin tomó la psicología de las facultades provista por su maestro Wundt como parámetro para establecer las discrepancias en las diferentes áreas de la vida psíquica anormal. Así, cada entidad se define de acuerdo a las perturbaciones que presente en el ámbito de la afectividad, de la voluntad y del juicio. Ejemplo de ello resulta la descripción de la *Dementia Praecox* en función de una serie de debilidades peculiares —indiferencia afectiva, pérdida volitiva y deterioro del juicio—, aspectos que, a su vez, resultan decisivos para establecer el diagnóstico diferencial con la paranoia.

A pesar de su trascendencia internacional, la Sexta edición del *Lehrbuch* no había sido editada en castellano hasta el día de hoy. Hemos elegido traducir varios apartados de una versión en inglés de la misma, publicada en Estados Unidos en el año 1990 como parte de una colección dedicada a la Historia de la Medicina⁵. En primer lugar, incluimos la introducción realizada por Kraepelin, en la que nos brinda una breve historia de la especialidad y declara su adhesión al paralelismo psicofísico:

«Los somatistas, encabezados por Nasse y Jacobi, declararon que la locura era la expresión de desórdenes físicos y lucharon con armas de investigación científica contra (...) concepciones ingenuas de la razón (...). Lo que se conquistó gracias a una ardua labor sesenta o setenta años atrás, se convirtió hoy en día en el postulado fundamental de nuestra ciencia: ya nadie pone en duda que los trastornos mentales son enfermedades que deben ser tratadas por un médico. En la actualidad sabemos que aquellos representan sólo las manifestaciones psíquicas de cambios cerebrales más o menos sutiles, particularmente del córtex.»⁶

En segundo lugar, ofrecemos al lector la traducción de la sección titulada «La clasificación de las enfermedades mentales», en la que el maestro alemán enuncia las diversas categorías de su nosografía y los criterios que la sustentan.

A continuación, seleccionamos el apartado concerniente al estudio de la *Dementia praecox*, cimiento de la categoría de esquizofrenia acuñada por Bleuler vigente hasta nuestros días. En él, Kraepelin realiza una notable descripción clínica de las formas que especifican el cuadro, cuya impronta puede advertirse en todos los manuales de la psiquiatría actual:

«Permítasenos, por el momento, clasificar en forma conjunta bajo el nombre de Dementia praecox una serie de cuadros clínicos cuya característica común consiste en una evolución signada por debilidades peculiares (...). Desde el punto de vista clínico, tal vez es recomendable, en pos de una mayor claridad, distinguir tres grupos principales de dementia praecox, sin embargo, están conectados entre sí por transiciones fluidas. Podemos llamar a estas formas hebefrénica, catatónica y paranoide. La primera es idéntica a la dementia praecox que he descrito anteriormente; la segunda cursa con catatonía, y la tercera abarca la dementia paranoide y además aquellos casos —hasta ahora considerados como parte de la paranoia— que llevan rápidamente a un estado de debilidad mental.»⁷

Finalmente, incluimos el capítulo sobre la Paranoia, entidad polémica que encontró tanto numerosos detractores como adeptos y que, a diferencia de la anterior, casi ha desaparecido de las clasificaciones contemporáneas. En dicho capítulo, Kraepelin explicita su punto de vista crítico frente a la concepción de la paranoia en boga hasta ese momento, por parecerle basada en una oposición artificial entre enfermedades de la razón y enfermedades de la afectividad. Asimismo, expresa su rechazo ante la inclusión de la paranoia aguda con recuperación promovida por Westphal, pues la misma daba un privilegio desmedido a la forma externa puramente sintomática del cuadro clínico. Kraepelin refuta este modo de pensar que no tiene en cuenta el curso y en el que el trastorno de la razón y la presencia de alucinaciones quedan como los únicos síntomas tangibles de la locura, porque conduce a agrupar a la paranoia con un conjunto de cuadros que no presenta ni los más mínimos rasgos comunes con ella. Estas son las razones que lo llevan a plantear la estrecha y homogénea delimitación de la paranoia que el lector podrá encontrar como punto nodal del capítulo:

«Considero sólo aquellos casos idénticos de enfermedad que, más allá de los incidentes particulares, muestran el mismo resultado en general. Ésta es la razón por la que opino que es absurda la afirmación de la existencia de una paranoia aguda, ya que en ella se ven completamente obliteradas las características esenciales de la enfermedad: la incurabilidad fundamental, la permanente presencia de delirios (...). Hay sin duda un grupo de casos donde un sistema delirante duradero, claramente reconocible desde el principio, se desarrolla gradualmente, a la vez que se conserva por completo el entendimiento y el orden del curso del pensamiento. Es para estas formas que quiero reservar el nombre de paranoia.»⁸

En todos los casos, las definiciones precisas y consistentes, la abundancia de ejemplos clínicos y la constante preocupación por los problemas relativos al diagnóstico diferencial, constituyen una referencia fundacional ineludible tanto para la psiquiatría como para el psicoanálisis.

Lic. Nora Carbone
Dr. Gastón Piazze

-
1. Kraepelin, E., *Lebenserinnerungen* [1919], Berlin, Springer Verlag, 1983.
 2. Kraepelin, E., «The classification of mental disorders», en *Psychiatry: A textbook for students and physicians*, vol. 2, Science History Publications, U.S.A., p. 3.
 3. Kraepelin, E., «Dementia Praecox», en *Psychiatry: A textbook for students and physicians*, vol. 2, Science History Publications, U.S.A., p. 103.
 4. Kraepelin, E., «The classification of mental disorders», op. cit., p. 3.
 5. Kraepelin, E., *Psychiatry: A textbook for students and physicians*, vol. 1 y 2, Science History Publications, U.S.A., 1990.
 6. Kraepelin, E., «Introduction», en *Psychiatry...*, op. cit., vol. 2, p. 2.
 7. Kraepelin, E., «Dementia Praecox», op. cit., p. 103.
 8. Kraepelin, E., «Paranoia», en *Psychiatry...*, op. cit., vol. 2, pp. 325-326.